

RELATÓRIO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO — GRO/NR-1

Metodologia de Governança, Integração AEP-ARP-PGR e Gestão de Mudanças

Escopo do Documento: Este relatório técnico estabelece a estrutura de governança e conformidade legal para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), focando na integração de fatores ergonômicos e riscos psicossociais, conforme as diretrizes da **Portaria MTE nº 1.419/2024** e da **NR-17**. Apresenta o plano operacional, o fluxo documental, a gestão de mudanças e ferramentas práticas prontas para execução operacional.

1. DIRETRIZES DE GOVERNANÇA E FLUXO DE IMPLANTAÇÃO

O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) não se limita ao cumprimento burocrático de entrega de documentos estáticos. Ele consiste em um processo dinâmico e contínuo focado na prevenção e proteção ativa da saúde do trabalhador. Para uma implementação segura, adota-se o **Fluxo Metodológico de 7 Etapas**, totalmente alinhado à lógica tripartite de SST e focado no ciclo PDCA de melhoria contínua:

- **Etapla 1 — Pontapé Inicial (Kickoff):** Reunião de alinhamento com a alta direção para nivelar conceitos, definir o escopo da implantação, alocar recursos (humanos, financeiros e de tempo) e formalizar o comitê de gestão multidisciplinar (integrando RH, SST, CIPA e Jurídico).
- **Etapla 2 — Desdramatização e Sensibilização:** Treinamento focado em líderes e supervisores para explicar o conceito técnico de riscos psicossociais e ergonômicos, desmistificando o tema e reduzindo resistências. Prepara a liderança para exercer escuta ativa e observar sinais e sintomas precoces de adoecimento.
- **Etapla 3 — Índice de Maturidade Psicossocial:** Realização de um diagnóstico passivo documental (junto ao RH e DP), analisando indicadores como absenteísmo, Fator Acidentário Prevencionário (FAP), atestados médicos (focando em CIDs dos Grupos M e F) e rotatividade, mapeando a situação em níveis de alerta (verde, amarelo e vermelho).
- **Etapla 4 — Metodologia de Triangulação de Campo:** Aplicação de um método técnico robusto para diagnóstico da realidade do trabalhador, cruzando três vertentes: (a) observação direta do posto e do ambiente de trabalho (trabalho real); (b) vivência dos trabalhadores por meio de entrevistas e grupos focais; e (c) análise documental das normas e políticas existentes.
- **Etapla 5 — Aplicação de Ferramentas Científicas:** Utilização opcional e criteriosa de questionários psicométricos validados no Brasil (como o COPSOQ II, Proart ou HSE). Evita-se o uso de ferramentas sem validação científica para não distorcer o diagnóstico nem gerar frustração nos colaboradores por falta de devolutiva.
- **Etapla 6 — Determinação de Riscos e Plano de Ação (5W2H):** Consolidação das notas de probabilidade e severidade na matriz de risco para cálculo do NRO. Definição conjunta (SST e Alta Direção) do cronograma, responsáveis nominados e formas de acompanhamento das medidas preventivas organizacionais.

- **Etapa 7 — Monitoramento Contínuo (Ciclo PDCA):** Acompanhamento sistemático do plano de ação, avaliando o risco residual após a implementação das medidas e retroalimentando o sistema diante de mudanças de processos ou inadequações identificadas.

2. INTEGRAÇÃO DOCUMENTAL E A CASCATA DA NR-1

Para evitar que as avaliações técnicas de saúde e segurança se tornem arquivos isolados e sem efeito prático, a NR-1 exige uma integração sistemática dos documentos em um fluxo de cascata indissociável. Essa integração garante que a saúde mental e os aspectos físicos do ambiente de trabalho converjam para o mesmo sistema de gestão:

Documento	Escopo e Finalidade	Como Alimenta o Próximo Nível
1. ARP (Avaliação de Riscos Psicossociais)	Diagnóstico específico dos fatores organizacionais e interpessoais que afetam a saúde mental.	Fundamenta a percepção do clima, organização do trabalho e demandas psicossociais, sendo subscrita na AEP.
2. AEP (Avaliação Ergonômica Preliminar)	Mapeamento preliminar de perigos ergonômicos físicos (mobiliário, postura) e cognitivos (psicossociais).	Sintetiza e consolida todos os apontamentos de ergonomia que geram esforço físico ou mental excessivo.
3. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)	Documento mestre obrigatório da NR-1 que unifica a gestão de todos os riscos da empresa.	Absorve o Inventário de Riscos consolidado da AEP e dispara formalmente o Plano de Ação (5W2H) com prazos.

Nota de Conformidade Legal (PCMSO): O Inventário de Riscos do PGR serve como fundamento primário para que o médico do trabalho elabore um PCMSO (NR-7) assertivo. Caso os exames clínicos ou o monitoramento da saúde apontem lesões, doenças ou exposições excessivas, o PCMSO atua como um gatilho de melhoria contínua, obrigando a empresa a reavaliar os riscos e as medidas preventivas existentes no PGR.

3. PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE MUDANÇAS E GATILHOS DE REAVALIAÇÃO

De acordo com o item 1.5.4.4.6 da NR-1, a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo. Embora exista o prazo regulamentar máximo de reavaliação de 2 anos (ou até 3 anos para organizações com sistemas de gestão de SST certificados sob a ISO 45001), existem **6 situações específicas de mudança ou desvio** que obrigam a revisão imediata do PGR e do inventário de riscos, antes do vencimento do calendário. Abaixo, essas situações estão descritas e traduzidas para a realidade prática operacional das empresas:

Gatilho da Norma (NR-1)	Tradução na Prática da Empresa	Responsável pelo Alerta
a) Após a implementação das medidas de prevenção	Avaliação do risco residual para comprovar se as ações do plano realmente reduziram a probabilidade ou severidade.	SST / Dono da Ação
b) Após inovações e modificações tecnológicas ou organizacionais	Reestruturação de departamentos, mudanças de escala, novos sistemas de software ou fusão de equipes.	Liderança do Setor
c) Quando identificada inadequação ou ineficácia das medidas	A medida preventiva foi executada, mas as reclamações de sobrecarga ou os desvios ergonômicos continuam iguais.	Operação / CIPA / SST
d) Na ocorrência de acidentes ou doenças do trabalho	Geração de CAT, afastamentos médicos longos ou retorno ao trabalho com restrições por distúrbios cognitivos ou ergonômicos.	Medicina do Trabalho
e) Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis	Atualização, publicação ou alteração oficial de Normas Regulamentadoras (MTE/SIT) que afetem a atividade.	Jurídico / SST
f) Após solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA	Demandas e reclamações formais enviadas pela comissão ou pelos trabalhadores sobre as condições reais do ambiente.	Trabalhadores / CIPA

4. FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA OPERAÇÃO DE SST

A. CHECKLIST DE CAMPO PARA OBSERVAÇÃO ERGONÔMICA ATIVA (AEP)

No processo de Triangulação de Ergonomia (Etapa 4), a observação ativa deve focar nas condições reais do trabalho, e não no que está apenas prescrito nos manuais. Utilize o checklist abaixo para realizar varreduras rápidas de ergonomia e fatores organizacionais em campo:

Item de Verificação	Critério de Avaliação Técnica (NR-17 / NR-1)	Status
1. Posto e Mobiliário	Os assentos possuem regulagens de altura e encosto? O espaço físico permite a alternância adequada entre a postura sentada e em pé?	☐ Conforme ☐ Alerta ☐ N/A
2. Ritmo e Demandas de Tempo	Há exigência de velocidade excessiva na execução de tarefas? Os colaboradores realizam horas extras exaustivas ou rotinas sem pausas?	☐ Conforme ☐ Alerta ☐ N/A

Item de Verificação	Critério de Avaliação Técnica (NR-17 / NR-1)	Status
3. Conforto Ambiental	A iluminação e as condições acústicas/térmicas estão adequadas ao tipo de atividade executada no setor?	☐ Conforme ☐ Alerta ☐ N/A
4. Clareza de Papéis	Os colaboradores compreendem as metas estabelecidas e a descrição das suas tarefas cotidianas de forma clara, sem ambiguidades?	☐ Conforme ☐ Alerta ☐ N/A
5. Suporte Social e Liderança	Existe canal aberto para diálogo e suporte diante de dificuldades operacionais? Há indícios de liderança autocrática ou abusiva?	☐ Conforme ☐ Alerta ☐ N/A

B. MODELO DE COMUNICAÇÃO INTERNA: SENSIBILIZAÇÃO E SEGURANÇA PSICOLÓGICA

A garantia de anonimato e sigilo absoluto é essencial para que os diagnósticos de riscos psicossociais sejam fidedignos. Sem essa segurança psicológica, os trabalhadores mascaram as respostas por medo de demissões ou retaliações. Utilize o modelo de comunicado oficial abaixo para sensibilizar os colaboradores antes de disparar formulários:

[LOGOTIPO DA EMPRESA / COMUNICADO OFICIAL]

Para: Todos os Colaboradores

Assunto: Implementação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (NR-1) — Cuidado com as Pessoas

Data: Setembro de 2026

Prezada equipe,

Com o compromisso de promover um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, seguro e acolhedor para todos, iniciamos uma nova etapa em nossa gestão de saúde e segurança. Em conformidade com as diretrizes da nova Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego, estamos realizando o mapeamento das condições ergonômicas e fatores psicossociais de nossa empresa.

Nos próximos dias, disponibilizaremos uma pesquisa para compreender sua percepção sobre a rotina de trabalho. Queremos destacar de forma expressa duas garantias inegociáveis desse processo:

1. Anonimato Absoluto: Suas respostas são totalmente anônimas e os dados serão compilados de forma estatística. Nenhum gestor ou colega terá acesso a respostas individuais, em estrito cumprimento à LGPD.

2. Sem Medidas Punitivas: Este mapeamento busca avaliar o *ambiente de trabalho* e seus processos, não o desempenho das pessoas. Suas respostas servirão unicamente para criar melhorias coletivas na organização, nos fluxos e no suporte à equipe.

Sua voz e sua opinião são os recursos mais valiosos para construirmos uma empresa melhor. Contamos com a participação ativa de todos!

Atenciosamente,

Diretoria de Recursos Humanos, SESMT e CIPA

Conformidade e Rastreabilidade Documental: Este documento técnico faz parte do acervo de processos do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) da organização. Toda a documentação e histórico de revisões do inventário e plano de ação deverão ser guardados e mantidos disponíveis à Inspeção do Trabalho pelo **prazo**

mínimo de 20 anos, conforme exigido pelo subitem 1.5.7.3.3.1 da NR-1.